

Etablissement

Médecin

PROTOCOLE MÉDICAL PRÉÉTABLI

Arrêt cardio-respiratoire

Conduite à tenir devant une personne inconsciente qui ne respire pas normalement.

Indications

- Résident inconscient, ne répondant pas aux stimulations.
- Respiration absente, anormale ou gasps.
- Effondrement brutal ou suspicion d'arrêt cardio-respiratoire.

Vérifications préalables

- Sécuriser les lieux rapidement.
- Vérifier absence de réponse et respiration normale.
- Faire alerter immédiatement le 15/112 et demander un DAE (Défibrillateur Automatisé Externe).
- Ne pas perdre de temps à rechercher des constantes.

Recommandations / IMPORTANT

- Ne pas attendre l'arrivée d'un médecin pour débiter les gestes.
- Ne pas interrompre les compressions sauf consigne, analyse DAE ou relais.
- Ne pas donner à boire, manger ou médicament.
- Ne pas déplacer sauf danger immédiat.

Conduite à tenir

- Appel 15/112 immédiat, haut-parleur si possible.
- Débiter compressions thoraciques au centre du thorax.
- Mettre en place le DAE (Défibrillateur Automatisé Externe) dès disponibilité et suivre ses consignes.
- Poursuivre RCP jusqu'au relais, reprise respiration normale ou épuisement.

Surveillance et traçabilité

- Tracer heure de découverte, début RCP, DAE, chocs éventuels et relais.
- Identifier témoins, circonstances et traitements connus.
- Organiser transmission aux secours et à l'établissement.

Alerte immédiate

- Appel 15/112 immédiat pour tout arrêt cardio-respiratoire suspecté.
- Faire prévenir encadrement sans retarder massage cardiaque et DAE.

Mention de sécurité

La survie dépend de l'alerte précoce, du massage cardiaque immédiat et de l'utilisation rapide du DAE.

Fait à :

Le : / /

Signature :